

TEMA 3.7 • UROLOGÍA

Prostatitis Aguda y Crónica

PERFIL EUNACOM 1.11.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **prostatitis** es una inflamación de la glándula prostática, generalmente de origen bacteriano, que representa una causa frecuente de consulta urológica y de síntomas urinarios en hombres jóvenes y de mediana edad. Se divide principalmente en dos formas clínicas: **aguda** y **crónica**, cada una con implicancias diagnósticas y terapéuticas distintas.

Etiología

La causa más común de prostatitis es la infección por **bacterias gram negativas** provenientes de la flora intestinal, las mismas que causan la mayoría de las **Infección del Tracto Urinario (ITU)**.

- **Escherichia coli**: Es, por amplio margen, el agente etiológico más frecuente.
- **Proteus mirabilis**: Segundo lugar en frecuencia.
- **Otras enterobacterias**: Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa.
- **Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)**: Aunque son menos frecuentes como causa de prostatitis aguda, en pacientes jóvenes con conductas de riesgo se debe considerar *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis*.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La infección suele ocurrir por vía ascendente a través de la uretra. El edema inflamatorio de la próstata puede comprimir la uretra prostática, lo que explica los síntomas obstructivos que acompañan al cuadro.

Prostatitis Aguda

Se presenta como un cuadro infeccioso sistémico de inicio súbito. Es fundamental reconocerla a tiempo para evitar complicaciones como el absceso prostático o la sepsis.

Clínica

La presentación suele ser indistinguible de una **Pielonefritis Aguda** en cuanto a la respuesta sistémica: - **Síntomas Sistémicos**: Fiebre alta, escalofríos, compromiso del estado general y mialgias. - **Síntomas Urinarios Irritativos**: Disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y orinas turbias/fétidas. - **Síntomas Obstructivos**: Dificultad para iniciar la micción, chorro débil o incluso retención aguda de orina (debido al edema prostático). - **Dolor**: Típicamente localizado en la zona perineal, región sacra o suprapúbica.

El Tacto Rectal (TR)

Es el pilar de la sospecha clínica. En la prostatitis aguda, la próstata se palpa: - Muy **dolorosa** (signo cardinal). - Caliente. - Edematosa o "pastosa".

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El tacto rectal en la fase aguda debe realizarse de forma **gentil**. Está estrictamente **contraindicado realizar un masaje prostático** vigoroso, ya que existe un alto riesgo de provocar una bacteriemia y diseminación de la infección (sepsis).

Diagnóstico

El diagnóstico de la prostatitis aguda es **fundamentalmente clínico**. - No se requieren exámenes de imagen confirmatorios de entrada. - Se debe solicitar **Urocultivo** para guiar el tratamiento antibiótico definitivo. - El sedimento urinario suele mostrar piuria y bacteriuria franca.

Prostatitis Crónica

Se define por la persistencia de síntomas por más de 3 meses. A diferencia de la aguda, el paciente no suele presentar compromiso

sistémico ni fiebre.

Clínica

- **Síntomas recurrentes**: El paciente relata episodios que parecen "cistitis" o ITUs a repetición. - **Dolor pélvico**: Molestia persistente en el periné, testículos o zona suprapúbica. - **Disfunción miccional**: Leve disuria o poliaquiuria intermitente.

Diagnóstico Diferencial y Confirmatorio

Dado que la clínica es más inespecífica, aquí sí se requieren estudios adicionales: 1. **Cultivo de líquido seminal**: Útil para identificar el germen. 2. **Prueba de los dos vasos (o cuatro vasos de Meares-Stamey)**: - Se toma un urocultivo antes del masaje prostático. - Se realiza un **masaje prostático** para obtener secreciones. - Se toma un urocultivo después del masaje. - **Interpretación**: Si el cultivo post-masaje tiene un recuento bacteriano significativamente mayor (10 veces más) que el pre-masaje, se confirma el origen prostático de la infección.

Manejo Terapéutico

El tratamiento se basa en antibióticos que tengan una buena penetración en el tejido prostático, el cual es habitualmente resistente a muchos fármacos debido a su pH y barrera hemato prostática.

Elección del Antibiótico

Las **Quinolonas** son el tratamiento de elección debido a su excelente biodisponibilidad en el tejido glandular. - **Ciprofloxacino**: Es el más utilizado. - **Levofloxacino**: Alternativa válida. - **Cotrimoxazol (Sulfas)**: Segunda línea en caso de alergia a quinolonas o resistencia demostrada.

Esquema de Tratamiento

TABLA 3.7.1: TIPO DE PROSTATITIS VS ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN

TIPO DE PROSTATITIS	ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Aguda	Ciprofloxacino 500 mg c/12h	4 a 6 semanas
Crónica	Ciprofloxacino 500 mg c/12h	6 semanas (mínimo)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: El error más común es tratar la prostatitis con cursos cortos de antibióticos (7 días). Debido a la mala penetración de los fármacos en la próstata, el tratamiento **nunca debe durar menos de 4 semanas** para asegurar la erradicación del germen y evitar la cronicación.

Resumen Comparativo

TABLA 3.7.2: CARACTERÍSTICA VS PROSTATITIS AGUDA		
CARACTERÍSTICA	PROSTATITIS AGUDA	PROSTATITIS CRÓNICA
Fiebre / Sistémico	Sí (frecuente)	No
Dolor al Tacto Rectal	Intenso / Muy dolorosa	Variable / Molestia leve
Masaje Prostático	Contraindicado	Necesario para diagnóstico
Diagnóstico	Clínico	Cultivos segmentados / Semen
Duración Tratamiento	4 - 6 semanas	6 semanas o más

NOTA CLÍNICA

Si un paciente con prostatitis aguda no mejora tras 48-72 horas de tratamiento antibiótico adecuado, se debe sospechar la formación de un **absceso prostático**, lo cual requiere evaluación con ecografía transrectal o tomografía.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de cuarenta y cinco años, sexo masculino, consulta por fiebre de treinta y ocho coma cinco, malestar general, disuria y polaquiuria de tres días de evolución. Al examen físico presenta tacto rectal muy doloroso con próstata aumentada de volumen. No tiene factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prostatitis Aguda y Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La prostatitis aguda es causada principalmente por Escherichia coli y Proteus mirabilis; las infecciones de transmisión sexual son infrecuentes aunque deben buscarse con factores de riesgo
- El hallazgo clínico cardinal de la prostatitis aguda que la diferencia de la pielonefritis es el tacto rectal extremadamente doloroso; el diagnóstico es clínico
- El tacto rectal en la prostatitis aguda debe realizarse con gentileza y sin masaje prostático para evitar diseminación de la infección
- El tratamiento de elección es ciprofloxacino por cuatro a seis semanas; las quinolonas son de los pocos antibióticos que penetran bien el tejido prostático
- La prostatitis crónica se confirma con cultivo de líquido seminal más dos urocultivos: uno antes y otro después del masaje prostático; si solo el posterior al masaje es positivo, confirma prostatitis crónica
- El tratamiento de la prostatitis crónica es ciprofloxacino por seis semanas obligatoriamente por la mayor cronicidad de la infección
- En pacientes alérgicos a quinolonas el cotrimoxazol es la alternativa de segunda línea para la prostatitis

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PROSTATITIS AGUDA Y CRÓNICA)**PREGUNTA 1**

Paciente de cuarenta y cinco años, sexo masculino, consulta por fiebre de treinta y ocho coma cinco, malestar general, disuria y polaquiuria de tres días de evolución. Al examen físico presenta tacto rectal muy doloroso con próstata aumentada de volumen. No tiene factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Ciprofloxacino por siete a diez días igual que una infección urinaria alta
- B)** Ciprofloxacino por cuatro a seis semanas porque las quinolonas penetran bien el tejido prostático
- C)** Ceftriaxona más doxiciclina para cubrir gonorrea y clamidia como primera línea
- D)** Amoxicilina por catorce días como antibiótico de amplio espectro de primera línea
- E)** Solo observación y analgesia porque el diagnóstico es clínico sin necesidad de antibióticos

PREGUNTA 2

Paciente de cincuenta años consulta por episodios recurrentes de síntomas urinarios como disuria y polaquiuria, y dolor pélvico crónico. No tiene fiebre. El tacto rectal no es doloroso. El sedimento de orina es negativo. ¿Qué exámenes se deben solicitar para confirmar el diagnóstico de prostatitis crónica?

- A)** Solo urocultivo para identificar el germen causante y guiar el tratamiento antibiótico
- B)** Cultivo de líquido seminal más urocultivo antes y después del masaje prostático
- C)** APE y ecografía vesico-prostática para descartar hiperplasia prostática benigna
- D)** Biopsia prostática transrectal para confirmar infección crónica del tejido prostático
- E)** PCR para gonorrea y clamidia en orina como primera línea diagnóstica

PREGUNTA 3

Paciente de treinta y cinco años con prostatitis aguda confirmada clínicamente. Es alérgico a las quinolonas con antecedente de reacción anafiláctica al ciprofloxacino. ¿Cuál es el antibiótico de segunda línea más adecuado?

- A)** Amoxicilina-clavulánico por catorce días
- B)** Nitrofurantoína por veintidós días
- C)** Cotrimoxazol por cuatro a seis semanas
- D)** Ceftriaxona intramuscular por siete días
- E)** Azitromicina en dosis única

RESUMEN: PROSTATITIS AGUDA Y CRÓNICA

La prostatitis aguda es una infección prostática que en la mayoría de los casos es causada por bacterias gram negativas de las infecciones urinarias habituales, siendo *Escherichia coli* la más frecuente y *Proteus mirabilis* la segunda causa. Las infecciones de transmisión sexual por gonorrea o clamidia son infrecuentes aunque deben buscarse en pacientes con factores de riesgo. Clínicamente se presenta como una pielonefritis aguda con fiebre, malestar general y síntomas urinarios como disuria y polaquiuria, más el hallazgo cardinal que la diferencia: el tacto rectal extremadamente doloroso. El tacto rectal debe realizarse con gentileza y sin masaje prostático porque el masaje puede diseminar la infección. El diagnóstico es clínico. El tratamiento de la prostatitis aguda se realiza con quinolonas, preferentemente ciprofloxacino, durante cuatro a seis semanas. La duración prolongada es fundamental porque el tejido prostático es difícil de penetrar con los antibióticos y se requiere tiempo para erradicar la infección completamente. En pacientes alérgicos a quinolonas se puede usar cotrimoxazol. Es importante recordar que no todos los antibióticos penetran bien el tejido prostático y las quinolonas son de las pocas familias que lo logran eficientemente. La prostatitis crónica tiene la misma etiología que la aguda pero se manifiesta con síntomas urinarios recurrentes más crónicos y dolor pélvico crónico. Por ser el cuadro clínico más inespecífico requiere confirmación diagnóstica con exámenes: cultivo de líquido seminal más dos urocultivos, uno previo y otro posterior al masaje prostático. Si el segundo urocultivo posterior al masaje resulta positivo y el previo era negativo, se confirma que la infección proviene de las secreciones prostáticas y corresponde a prostatitis crónica. El tratamiento es el mismo que en la aguda, ciprofloxacino, pero durante seis semanas obligatoriamente por ser una infección más crónica y arraigada.